·专题研究·康复治疗·

开窍解喑针刺法及头针结合语言强化训练在恢复期缺血性脑卒中并发失语症患者中的应用

刘晓雅，尹姣姣，张蕊，谢卫红，郝卫平，曾小雨

【摘要】 **目的** 探究开窍解喑针刺法及头针结合语言强化训练在恢复期缺血性脑卒中并发失语症患者康复中的治疗效果。**方法** 选取2023年3月至2025年3月漯河医学高等专科学校第三附属医院收治的82例恢复期缺血性脑卒中患者，随机分为对照组与观察组。比较两组治疗疗效、中医证候积分、语言功能、颅内血流动力学及日常生活能力。**结果** 干预2周后，观察组治疗总有效率92.68%显著高于对照组73.17%(P<0.05)；观察组中医证候积分明显低于对照组(P<0.05)；观察组西方失语症成套测验各维度得分均显著高于对照组(P<0.05)；观察组前、中、后动脉流速均明显高于对照组(P<0.05)；观察组Barthel指数得分显著高于对照组(P<0.05)。**结论** 开窍解喑针刺法及头针结合语言强化训练对恢复期缺血性脑卒中并发失语症患者的治疗效果较好，可改善患者语言功能和颅内血流动力学，提高日常生活能力。

【关键词】 开窍解喑针刺法；头皮针疗法；缺血性脑卒中；失语症

Application of Kaiqiao Jieyin Acupuncture and Scalp Acupuncture Combined with Language Reinforcement Training in Patients with Ischemic Stroke Complicated by Aphasia during the Recovery Period

LIU Xiaoya,YIN Jiaojiao,ZHANG Rui,XIE Weihong,HAO Weiping,ZENG Xiaoyu

【Abstract】 **Objective** To explore the therapeutic effect of Kaiqiao Jieyin acupuncture(opening orifices and removing aphonia) and scalp acupuncture combined with language reinforcement training in the rehabilitation of patients with ischemic stroke complicated with aphasia during the recovery period. **Methods** A total of 82 patients with ischemic stroke in the recovery period admitted to the Third Affiliated Hospital of Luohe Medical College from March 2023 to March 2025 were selected and randomly divided into a control group and an observation group. The therapeutic effects, TCM syndrome scores, language functions, intracranial hemodynamics and activities of daily living of the two groups were compared. **Results** After two weeks of intervention, the total effective rate of treatment in the observation group was 92.68%, which was significantly higher than that in the control group 73.17%(P<0.05). The TCM syndrome score of the observation group was significantly lower than that of the control group(P<0.05). The scores of each dimension of the Western aphasia complete test in the observation group were significantly higher than those in the control group(P<0.05). The arterial velocities of the anterior, middle and posterior arteries in the observation group were significantly higher than those in the control group(P<0.05). The Barthel index score of the observation group was significantly higher than that of the control group(P<0.05). **Conclusion** Kaiqiao Jieyin acupuncture and scalp acupuncture combined with language reinforcement training, has a good therapeutic effect on patients with ischemic stroke complicated with aphasia during the recovery period. It can improve the language function and intracranial hemodynamics of patients and enhance their ability to perform daily living.

【Keywords】 Kaiqiao Jieyin acupuncture;Scalp acupuncture;Ischemic stroke;Aphasia

缺血性脑卒中作为全球范围内致残率最高的脑血管疾病之一，其高发病率与高致残率给患者生活质量及社会医疗资源造成了沉重负担[1]。据统计，我国每年新发脑卒中病例超过200万，其中约70%为缺血性脑卒中，而高达30%~40%的患者在急性期后会遗留不同程度的语言功能障碍[2-3]。失语症不仅导致患者交流能力丧失，还可能引发抑郁、社交隔离等心理问题，进一步降低康复依从性，形成恶性循环[4]。语言强化训练作为现代康复的基石，虽能通过重复性任务促进神经重塑，但单一训练模式的疗效有限，目前亟需探索更高效、多模态的干预策略[5]。失语症属于中医范畴中的“舌强”与“不语”范畴，其发病主要与心、肾关系密切，病位在脑，传统中医疗法在脑卒中后功能障碍的康复中具有独特优势。其中开窍解喑针刺法以醒脑开窍、通络利咽为理论核心，通过刺激特定穴位能有效调节脑部气血运行，近年来在改善语言功能方面显示出潜在价值[6]。与此同时，头针疗法作为微创针刺技术，通过刺激大脑皮层投射区(如语言区对应的额颞部头针带)可直接调节神经电活动，但其在失语症康

基金项目：漯河医学高等专科学校2024年度校级科技创新项目(KJCXSFY202406)
文章编号：1005-619X(2025)12-056-04
DOI 编码：10.13517/j.cnki.ccm.2025.12.013
作者单位：漯河医学高等专科学校第三附属医院(漯河市康复医院)神经康复科，河南 漯河 462000
通信作者：刘晓雅 13939529766@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

复中的精准应用方案仍需循证支持[7]。现有研究多聚焦于针刺的独立疗效，其与西医康复技术的协同机制尚未充分阐明。因此，本研究通过整合头针的“靶向干预”与语言训练的“功能再塑”，以期为临床治疗恢复期缺血性脑卒中并发失语症患者提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2023年3月至2025年3月于漯河医学高等专科学校第三附属医院治疗的82例恢复期缺血性脑卒中患者，按照随机数字表分成对照组与观察组，每组41例。两组均未见脱落病例，两组一般临床资料分布均衡，存在可比性(P>0.05)，见表1。本研究经医院伦理委员会审核批准(批准文号：202309)。

表1 两组患者一般资料比较[($\bar{x}$±s)，n(%)]

项目	对照组(n=41)	观察组(n=41)	t(χ^2)值	P值
年龄/岁	50.19 ± 10.04	49.36 ± 12.21	0.336	0.738
病程/d	62.28 ± 15.01	64.11 ± 14.17	0.568	0.572
性别			1.334	0.248
男	29(70.73)	24(58.54)		
女	12(29.27)	17(41.46)		
失语症类型			0.546	0.909
运动性	19(46.34)	17(41.46)		
感觉性	10(24.39)	12(29.27)		
经皮质性	9(21.95)	10(24.39)		
命名性	3(7.32)	2(4.88)		
卒中部位			0.479	0.787
额叶前部	23(56.10)	20(48.78)		
额叶上部	10(24.39)	11(26.83)		
额下回后部	8(19.51)	10(24.39)		

1.2 诊断标准 中医诊断标准[8]：主证包括口舌歪斜、言语謇涩、半身不遂；次证包括气短乏力、面色无华、自汗出；舌质暗淡或瘀斑，舌苔薄白或腻；脉沉细、细弦或细缓，同时满足以上全部主证、舌象、脉象并伴有2项以上次证者即可诊断。西医诊断标准：均满足急性缺血性脑卒中恢复期与失语症相关诊断标准[9-10]，距离最近一次发病1~6个月，临床表现为无法复述、模仿复述或错误复述、口语表达障碍、命名障碍、口语理解障碍、阅读障碍、书写障碍，西方失语症成套测验(WAB)指数<93.8分，即可诊为失语症。

1.3 选取标准 纳入标准：均满足上述诊断标准；均为恢复期缺血性脑卒中；年龄18~75岁；母语为汉语；均签署知情同意书。排除标准：发病前存在失语；因其他因素导致失语，包括发音、构音器官病变；针刺部位皮肤受损；合并其他引起失语的中枢性疾病；存在智力、听力、视力障碍；精神系统疾病；严重心、肝、肾疾病或传染病。脱落标准：自行退出研究；治疗依从性较差；出现严重不良反应或病情恶化；病历资料不全。

1.4 方法 所有患者均接受抗血小板聚集、控制血压、改善脑循环等基础治疗，对照组患者予以语言强化训练，训练内容为①听力、理解能力训练：由护理人员发放张嘴、摇头、点头等动作指令，由护理人员提出问题，要求患者结合发放的指令动作回答，依据患者的回答状况调整难度，逐步由单项调整为复合。②口语能力训练：护理人员指导患者在镜子前模仿正常口型训练，逐步从拼音过渡至字词。③阅读能力：打乱字卡顺序，由患者拼组出正确顺序使其成为连续完整的一句话，逐步将字卡替换为拼图、文章。④复读训练：护理人员借助日常用语、诗词、实物要求患者复述，按照简单的单词、单句、复句顺序调整难度。训练时间0.5~1.0 h/次，1次/d，5 d/周。

观察组患者在此基础上联合使用开窍解喑针刺法及头针治疗，取穴[11]：言语一区(前后正中线中点后0.5 cm及鬓角前缘与眉枕线交点连线下2/5处)、言语二区(以顶骨结节后下2 cm处为起点，作一条与前后正中线平行并延长3 cm的直线)、天突、风池、廉泉、旁廉泉(廉泉穴左右各旁开3 cm)、通里。操作方法：患者取仰卧位，使用0.3 mm×0.4 mm一次性无菌针灸针，言语一区、二区：针尖以30°角刺入头皮，进入帽状腱膜下层，待指下出现松软感时，将针身调整至与头皮呈15°角刺入25 mm，得气后，行捻转平补平泻手法：捻转幅度为180°~360°，频率为200次/min，持续20 s；天突：直刺6 mm后改沿气管前缘、胸骨柄后缘缓刺25 mm，风池：向鼻尖方向斜刺25 mm，通里：直刺15 mm，三穴得气后行捻转平补平泻(频率为90次/min，持续20 s)；旁廉泉、廉泉：患者头稍后仰，向舌根方向刺入25~35 mm，得气后行提插捻转平补平泻(频率为90次/min+提插3~5 mm，持续20 s)，每15 min行针1次，留针30 min，1次/d，5 d/周。两组均连续干预2周。

1.5 观察指标 ①治疗疗效：于干预2周后进行疗效判定，参考《汉语标准失语症检查法的编制与常模》[12]，治愈：患者理解、书写、复述等语言功能评分总分提高90%以上；显效：总分提高60%~90%；有效：总分提高>30%~<60%；无效：总分提高≤30%。总有效率=(治愈+显效+有效)例数/总例数×100%。②中医证候积分[8]：分别于干预前后对中医证候进行赋分，主证分别赋以0、2、4、6分，次证赋以0、1、2、3分，得分越高证候越严重。③语言功能：分别于干预前后应用WAB[13]进行评估，量表包含复述(100分)、理解(200分)、命名(90分)、自发言语(20分)4个部分，得分越高言语功能越好。④颅内血流动力学：分别于干预前后应用经

中国知网 https://www.cnki.net

颅多普勒超声检测前、中及后动脉流速。⑤日常生活能力：分别于干预前后使用 Barthel 指数(BI)进行评估，量表共包括 10 个项目，满分 100 分，得分越高表明日常生活能力越强。

1.6　统计学方法　采用 SPSS 24.0 软件对数据进行统计学分析，计数资料以率[n(%)]表示，采用 χ^2 检验，等级资料采用秩和检验；计量资料以均数 ± 标准差($\bar{x}\pm s$)表示，采用 t 检验，$P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2　结果

2.1　两组患者疗效比较　观察组治疗总有效率显著高于对照组($P<0.05$)，见表 2。

2.2　两组患者日常生活能力评分比较　干预前，两组 BI 评分比较差异无统计学意义($P>0.05$)；干预后，两组 BI 评分均上升，且观察组明显高于对照组($P<0.05$)，见表 3。

2.3　两组患者中医证候积分比较　干预前，两组中医证候积分比较差异无统计学意义($P>0.05$)；干预后，两组中医证候积分均下降，且观察组显著低于对照组($P<0.05$)，见表 4。

2.4　两组患者语言功能评分比较　干预前，两组 WAB 各维度得分差异均无统计学意义($P>0.05$)；干预后，两组 WAB 各维度得分均上升，且观察组均显著高于对照组($P<0.05$)，见表 5。

2.5　两组患者颅内血流动力学比较　干预前，两组前、中、后动脉流速比较差异无统计学意义($P>0.05$)；干预后，两组前、中、后动脉流速均上升，且观察组均显著高于对照组($P<0.05$)，见表 6。

表 2　两组患者疗效比较[n(%)]

组别	例数	治愈	显效	有效	无效	总有效率
对照组	41	16(39.02)	8(19.51)	6(14.63)	11(26.83)	30(73.17)
观察组	41	22(53.66)	14(34.15)	2(4.88)	3(7.32)	38(92.68)
Z值			2.221			
P值			0.027			

表 3　两组患者日常生活能力评分比较($\bar{x}\pm s$)　单位：分

组别	例数	干预前	干预后
对照组	41	53.62 ± 10.16	59.43 ± 13.40*
观察组	41	52.16 ± 10.71	66.43 ± 15.21*
t值		0.633	2.211
P值		0.528	0.030

注：与同组干预前比较，*$P<0.05$。

表 4　两组患者中医证候积分比较($\bar{x}\pm s$)　单位：分

组别	例数	口舌歪斜		言语謇涩		半身不遂	
		干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
对照组	41	4.14 ± 1.15	2.71 ± 0.75*	4.11 ± 1.17	2.62 ± 0.78*	2.05 ± 0.72	1.19 ± 0.36*
观察组	41	4.29 ± 1.27	2.30 ± 0.66*	4.19 ± 1.36	2.15 ± 0.62*	2.18 ± 0.79	1.02 ± 0.27*
t值		0.561	2.628	0.286	3.020	0.779	2.419
P值		0.577	0.010	0.776	0.003	0.438	0.018

组别	气短乏力		面色无华		自汗出	
	干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
对照组	1.72 ± 0.58	1.21 ± 0.31*	1.74 ± 0.57	1.15 ± 0.32*	1.61 ± 0.48	1.66 ± 0.52
观察组	1.83 ± 0.63	0.94 ± 0.24*	1.88 ± 0.61	0.82 ± 0.22*	1.17 ± 0.41*	0.94 ± 0.30*
t值	0.896	4.410	1.074	5.441	0.452	2.899
P值	0.373	<0.001	0.286	<0.001	0.652	0.005

注：与同组干预前比较，*$P<0.05$。

表 5　两组患者语言功能评分比较($\bar{x}\pm s$)　单位：分

组别	例数	复述		理解		命名		自发言语	
		干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
对照组	41	37.85 ± 6.54	53.31 ± 10.05*	68.43 ± 12.02	112.26 ± 26.69*	41.15 ± 10.05	59.93 ± 5.87*	6.28 ± 1.66	13.36 ± 3.17*
观察组	41	38.11 ± 7.13	68.72 ± 13.36*	66.61 ± 13.36	135.53 ± 30.11*	43.39 ± 12.26	69.23 ± 8.11*	6.95 ± 2.03	16.49 ± 3.67*
t值		0.172	5.902	0.648	3.703	0.905	5.948	1.636	4.133
P值		0.864	<0.001	0.519	<0.001	0.368	<0.001	0.106	<0.001

注：与同组干预前比较，*$P<0.05$。

表 6　两组患者颅内血流动力学比较($\bar{x}\pm s$)　单位：cm/s

组别	例数	前动脉流速		中动脉流速		后动脉流速	
		干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
对照组	41	31.84 ± 7.75	38.46 ± 10.05*	42.26 ± 6.13	57.71 ± 8.05*	34.51 ± 6.21	33.02 ± 6.72
观察组	41	32.11 ± 7.11	45.57 ± 8.42*	43.17 ± 7.05	63.18 ± 10.02*	40.11 ± 8.43*	47.41 ± 10.05*
t值		0.164	3.472	0.624	2.275	1.043	0.300
P值		0.870	0.001	0.535	0.008	3.563	0.001

注：与同组干预前比较，*$P<0.05$。

中国知网　https://www.cnki.net

3 讨论

失语作为缺血性脑卒中后最常见的并发症之一，现代医学认为，失语症的发生与大脑皮质受损导致语言功能及相关控制区继发损伤有关，严重影响了患者的日常生活。语言康复训练是临床应用最广泛的干预方案，能有效刺激语言中枢与受抑制通路，改善语言功能，但该干预方案易受到主观因素影响，故临床在开展的同时需结合其他干预方法。

中医认为，失语症病因为风、痰、火、瘀阻滞心神，病位在脑，临床见言语謇涩、气短乏力等证候，这与《黄帝内经》中“心主言”“脑为元神之府”的理论高度吻合，其核心病机可概括为“本虚标实”，本虚在于肾精亏虚、髓海不足，标实则为风、火、痰、瘀阻滞脑络[14]。本研究结果显示，观察组治疗总有效率高于对照组，中医证候积分低于对照组，表明开窍解喑针刺法及头针结合语言强化训练能提高治疗效果。分析可能与开窍解喑针刺法及头针的整体调节作用有关，言语一区位于额下回后部，与“脑户”相邻，《针灸大成》载：“脑户，主目赤痛，头重项强，失音不语”，针刺该区可通督醒脑，开音利窍；言语二区位于颞上回后部，对应“玉枕”区域，《针灸甲乙经》谓其主“头项痛，目泣出，鼽衄，项强”，刺激该区可清头明目，通络开窍；天突为任脉与阴维脉交会，针刺该穴有宣肺降逆，利咽开音之效；风池为足少阳与阳维脉交会，针刺该穴可祛风通络，清利头目；廉泉为任脉与阴维脉交会，针刺该穴有通利咽喉，开窍启闭之效，配合旁廉泉可加强通络利咽之效；通里为手少阴心经络穴，针刺该穴有宁心安神，通络开音之效，诸穴合用可疏通督脉经络，治神、养神[15-16]。本研究还显示观察组WAB各维度得分均高于对照组，提示开窍解喑针刺法及头针结合语言强化训练可改善语言功能。这种优势主要源于针刺的精准刺激与语言强化训练的协同作用，现代药理证实，针刺言语一区可通过局部微电流刺激促进神经突触可塑性，增强语言运动计划的输出能力；针刺言语二区可改善听觉语言信息的整合与理解能力[17]。针刺天突穴可提高喉返神经传导速度，廉泉穴可直接作用于舌下神经，改善构音器官的运动功能[18]。本研究还显示，观察组前、中、后动脉流速均高于对照组，表明开窍解喑针刺法及头针结合语言强化训练能有效改善颅内血流量。这可能是因为针刺刺激可通过上调内皮型一氧化氮合酶表达，促进一氧化氮的释放，从而改善脑血管舒张功能，刺激风池穴可调节血清内皮素-1水平，优化脑血管自动调节功能[14]。此外，本研究中，观察组BI评分均高于对照组，表明开窍解喑针刺法及头针结合语言强化训练能有效改善患者日常生活能力。这可能是因为开窍解喑针刺法及头针结合语言强化训练带来的治疗效果提高了患者语言交流能力，有效增强了患者治疗自信心，语言功能的改善为患者带来了正向反馈，增强了患者的社交自信心，改善了患者的情绪状态。

综上所述，对恢复期缺血性脑卒中并发失语症患者予以开窍解喑针刺法及头针结合语言强化训练治疗效果较好，可改善患者语言功能、颅内血流动力学、日常生活能力，有着重要的临床推广价值。

参考文献

[1] 王仕鸿，赖凤霞，张之怡，等.2020—2040年中国缺血性脑卒中流行趋势预测[J]. 中国神经免疫学和神经病学杂志，2024，31(6)：459-467.

[2] 伞小旭，王健. 缺血性脑卒中风险评估模型研究进展[J]. 中西医结合心脑血管病杂志，2023，21(1)：93-96.

[3] 马艳平，荆静，王艳琴，等. 正中神经电刺激联合语言训练治疗脑卒中后失语症患者的疗效观察[J]. 中华物理医学与康复杂志，2025，47(6)：506-509.

[4] 杨珊，王恺，刘念，等. 督脉针刺合舌三针联合康复训练对老年脑卒中失语症患者语言功能、认知水平及炎症因子的影响[J]. 中国老年学杂志，2023，43(19)：4630-4633.

[5] 姚珊，盛超，王旭霞，等. 高压氧联合Schuell语言训练治疗脑卒中后失语症患者的疗效及其对语言中枢活动功能的影响[J]. 中华航海医学与高气压医学杂志，2023，30(5)：568-571.

[6] 李昭缘，林万隆，齐瑞.“开窍解喑”法针刺联合重复经颅磁刺激治疗卒中后失语症：随机对照试验[J]. 中国针灸，2023，43(1)：25-28.

[7] 陈柱，夏家怡，徐倩，等. 头针联合镜像神经元训练改善脑卒中后非流利性失语症的作用[J]. 中国听力语言康复科学杂志，2022，20(3)：222-225.

[8] 国家中医药管理局. 中医病证诊断疗效标准[S]. 南京：南京大学出版社，1994：203-205.

[9] 中华医学会神经病学分会脑血管病学组急性缺血性脑卒中. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010[J]. 中国全科医学，2011，14(35)：4013-4017.

[10] 高素荣. 失语症[M].2版. 北京：北京大学医学出版社，2006：516-518.

[11] 闵友江，姚海华，邵水金，等. 浅析《头针穴名国际标准化方案》的科学性[J]. 中国针灸，2007，27(8)：612-616.

[12] 李胜利，肖兰，田鸿，等. 汉语标准失语症检查法的编制与常模[J]. 中国康复理论与实践，2000，6(4)：162-164，封三.

[13] 李嘉洋，梁韵瑾，欧阳嘉璐，等.WAB汉化版失语症诊断量表的信度与效度分析[J]. 现代语言学，2022(5)：821-828.

[14] 李昭缘，张建忠，张思聪，等. 针刺治疗脑卒中后失语症的研究进展[J]. 西部中医药，2023，36(6)：149-152.

[15] 李雪青，邓娟娟，熊丽，等. 开玄醒神针法联合Schuell刺激法治疗缺血性脑卒中后运动性失语症的临床观察[J]. 广州中医药大学学报，2023，40(1)：101-106.

[16] 赵德福，赵瑜，杨孝芳. 督脉取穴针刺联合Schuell语言康复训练对脑卒中后失语症患者言语功能、MoCA评分及语言中枢活动功能的影响[J]. 临床和实验医学杂志，2021，20(8)：886-890.

[17] 林冰冰，倪静蕾，熊啸，等. 基于功能性近红外光谱技术探讨头皮针联合言语康复训练对脑卒中后失语症患者的影响[J]. 康复学报，2024，34(6)：590-596.

[18] 李雪青，邓娟娟，熊丽，等. 通络醒神针法联合缪刺法治疗脑卒中后运动性失语症临床研究[J]. 天津中医药大学学报，2023，42(1)：24-28.

(收稿日期：2025-08-22；修回日期：2025-09-11)
(本文编辑：王红霞)

中国知网 https://www.cnki.net